"피 묽게 하는 약", 제대로 알기

내가 먹는 '피 묽게 하는 약' — 항혈소판제·항응고제, 종류와 주의점을 한눈에

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 결론 — '피 묽게 하는 약' 세 가지 약속

같은 '피 약'이라도 종류마다 쓰임과 주의점이 다릅니다

1

내 약이 무엇인지 압니다

항혈소판제인지 항응고제인지에 따라 막는 혈전도, 주의할 점도 다릅니다. 약 이름을 적어 두세요.

약 이름 적어 두기

2

스스로 끊지 않습니다

특히 **스텐트 시술** 뒤에는 하루만 끊어도 스텐트 안에 피가 굳을 수 있습니다. 조정은 처방 의사와 정합니다.

끊기 전에 먼저 상의

3

출혈 신호는 바로 응급실

검은 변·피를 토함·갑작스러운 **심한 두통**이나 한쪽 마비는 기다리지 말고 응급실로 가세요.

약 이름·마지막 복용 시각 알리기

Tip · 치과·내시경·수술 전에는 꼭 복용 중인 '피 약'을 먼저 알려 주세요.

근거 · 2025 ACC/AHA · 2024 ESC

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다리 혈관 시술 뒤 약 계획은 따로 정합니다

시술 부위와 종류, 출혈 위험, 다른 항응고 치료를 함께 봅니다

1

시술 직후 두 가지 약

하지 혈관 스텐트·풍선 시술 뒤에는 아스피린과 **클로피도그렐**을 함께 쓰는 기간을 정합니다.

2

보통 1~3개월

하지 스텐트의 두 약 병용은 **보통 1~3개월**, 길어야 6개월입니다. 처방받은 기간을 지키세요.

3

이후 한 가지 약

단일 **항혈소판제**를 평생 유지하는 계획입니다. 출혈이 생기거나 심방세동 등으로 항응고제가 필요해지면 조정합니다.



심장 혈관의 병용 기간을 다리 혈관 시술에 그대로 적용하지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 말초동맥질환, 언제 의심하고 어떻게 치료할까?(김태오)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

다리 동맥 약은 목적이 다릅니다

심근경색·뇌졸중을 막는 약과 걷는 거리를 늘리는 약을 구분합니다

01

아스피린·클로피도그렐

증상이 있는 말초동맥질환에서 심근경색·뇌졸중·혈관 사망을 줄이는 목적입니다. 둘 중 한 가지를 기본으로 씁니다.

02

실로스타졸

파행으로 걷기 힘들 때 보행거리 개선을 위해 더하는 약입니다. 사건 예방 약을 대신하지 않으며 **심부전**에는 쓰지 않습니다.

03

선택된 고위험 환자

아스피린과 저용량 **리바록사반 2.5 mg**을 하루 2회 함께 쓰는 방법이 있습니다. 모든 항응고제·용량에 해당하지 않습니다.

04

병용 선택

허혈 위험과 **출혈 위험**에 맞춰 선택합니다. 아스피린·리바록사반·실로스타졸 세 약을 모두 얹는 조합은 권하지 않았습니다.

무증상인 분의 항혈소판제는 위험인자를 보고 개별적으로 정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 말초동맥질환, 언제 의심하고 어떻게 치료할까?(김태오)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

‘피 약’은 크게 세 종류입니다

어디에 생기는 혈전을 막느냐에 따라 나뉩니다

	항혈소판제	항응고제	혈전용해제
무엇을 하나	혈소판이 뭉치는 것을 막음	피가 굳는 단백질을 막음	이미 생긴 혈전을 녹임
주로 막는 병	심근경색 · 뇌경색 · 다리 동맥	심방세동 · 정맥 혈전	급성 뇌경색·심근경색 응급
예	아스피린, 클로피도그렐	와파린, 새 경구 항응고제(4종)	병원에서 주사로만

Tip · 심방세동에 아스피린·클로피도그렐을 ‘혈액순환제’처럼 쓰는 것으로는 뇌졸중 예방이 부족합니다.

근거 · 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS · 2024 ESC

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

파행 약은 걷는 거리와 증상으로 평가합니다

혈전 사건 예방 약과 실로스타졸의 목적을 나누어 이해합니다

01

교재의 보행거리 수치

실로스타졸은 12~24주 치료에서 보행거리가 50~67% 증가한 결과를 제시했습니다. 걷기 증상 개선을 보는 약입니다.

02

심부전에는 금기

심부전이 있으면 중증도와 관계없이 **실로스타졸**을 쓰지 않습니다. 현재 질환과 복용 약을 알려 주세요.

03

운동 프로그램과 함께

감독하 걷기 운동을 약물치료와 함께 합니다. **통증**이 유발될 때까지 걷고 쉬기를 반복하며 강도는 의료진이 정합니다.

04

사건 예방은 따로

아스피린·**클로피도그렐**은 심근경색·뇌졸중 등 예방 목적입니다. 실로스타졸로 바꾸어 대신하는 약이 아닙니다.

심부전 병력이 있으면 약을 시작하기 전에 꼭 알리세요.

동맥 혈전과 정맥 혈전은 재료가 다릅니다

그래서 막는 약도 달라집니다

동맥 — 하얀 혈전

피가 빠르게 흐르는 동맥에서 혈관 벽이 다친 곳에
혈소판이 뭉쳐 생깁니다. → 항혈소판제로 막습니다.

정맥·심장 — 붉은 혈전

피가 느리게 고이는 곳에서 굳는 단백질 그물에
적혈구가 갇혀 생깁니다. → 항응고제로 막습니다.

그래서

내 병이 어느 쪽 혈전을 막아야
하는지에 따라 약이 정해집니다.

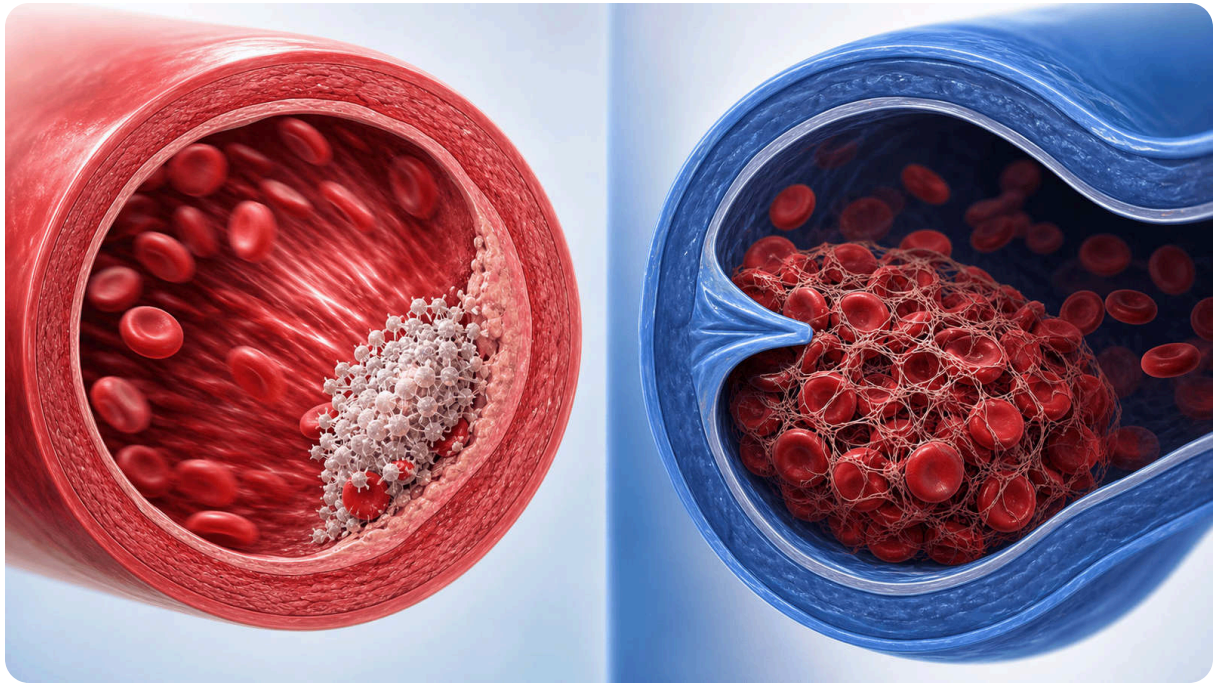


그림 · 왼쪽 동맥의 흰 혈전(혈소판), 오른쪽 정맥의 붉은 혈전(적혈구)입니다(설명용 그림).

근거 · 혈전 형성의 세 요소(피 흐름·혈관 벽·응고)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

항혈소판제 — 약마다 주의할 점

혈소판이 뭉치지 않게 해 동맥이 막히는 것을 막는 약입니다

01

아스피린

효과가 **7~10일** 갑니다. 위가 헐거나 피가
날 수 있어 위 보호약을 함께 쓰기도 합니다.

02

클로피도그렐

몸 안에서 바뀌어야 효과가 나는 약입니다. 한국인은
효과가 약하게 나는 분이 많아 의사가 따져 고릅니다.

03

티카그렐러 · 프라수그렐

효과가 더 강한 약입니다. **티카그렐러**는 숨이 차는 느낌이 올
수 있고, 프라수그렐은 뇌졸중을 겪은 분은 쓰지 않습니다.

04

실로스타졸

혈관도 넓혀 줍니다. 처음 며칠 두통·두근거림이
흔하고, **심부전**이 있으면 쓰지 않습니다.

Tip · 새로 약을 처방받을 때 지금 먹는 '피 약' 이름을 꼭 말씀해 주세요.

근거 · 각 약제 허가 정보 · 2025 ACC/AHA

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

뇌동맥류가 있어도 다른 병의 약을 함께 판단합니다

뇌동맥류 병력만으로 처방받은 항혈전제를 스스로 중단하지 마세요

01

스텐트를 사용한 경우

두 **항혈소판제**를 3~6개월 사용하고, 아산병원은
3개월 뒤 아스피린 단독을 1년~1년 반 유지합니다.

02

장기 복용은 개별 결정

허혈성 뇌졸중 위험인자가 있는 고령 환자에서는
아스피린을 더 오래 유지하기도 한다고 설명했습니다.

03

항혈소판제와 항응고제

심장·뇌혈관 질환의 **항혈소판제**와 심방세동의 항응고제는
쓰는 이유가 다릅니다. 현재 약과 복용 이유를 알려 주세요.

04

출혈과 혈전 위험 함께

관찰 중인 **저위험 뇌동맥류**만으로 항혈전·항응고 치료를
금기하지 않습니다. 파열 시 출혈은 더 많을 수 있습니다.

연자의 Q&A 답변입니다. 약의 유지·변경은 처방기관과 상의합니다.

아산 28회 연수강좌 — 검진에서 발견된 뇌동맥류: 어떻게 추적하고 언제 치료할까?(박중철)

와파린과 새 경구 항응고제

심방세동의 뇌졸중 위험과 판막 상태를 보고 항응고제를 고릅니다

와파린

오래 써 온 약입니다. **피검사**로 효과를 맞춥니다.

- 정기적으로 피검사(INR)를 해 용량을 조절합니다
- 음식·다른 약의 영향을 많이 받습니다
- 기계 판막은 와파린을 쓰며 중등도 이상의 승모판 협착도 와파린이 우선입니다

새 경구 항응고제(4종)

다비가트란·리바록사반·아픽사반·에독사반입니다.

- 정기 피검사로 용량을 맞출 필요가 없습니다
- 와파린보다 뇌출혈이 적습니다
- 콩팥 기능에 따라 용량을 정하니 콩팥 검사는 챙깁니다

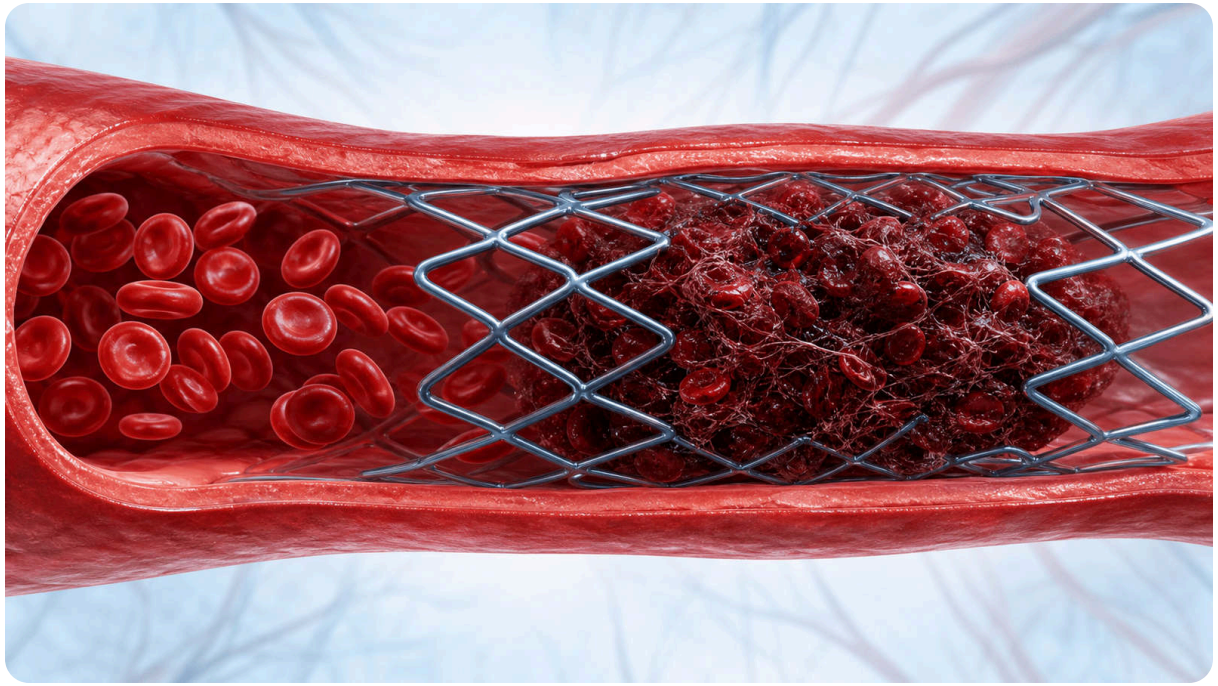
Tip · 임신 중이거나 계획 중이면 바로 처방 의사·산부인과에 알리세요. 두 약 모두 다시 검토해야 합니다(스스로 끊지 않기).

근거 · 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS · 2024 ESC

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

스텐트 시술 뒤 약, 임의로 끊으면 안 됩니다

스텐트 안에서 피가 굳으면 심근경색·돌연사로 이어질 수 있습니다



두 가지 약을 함께

아스피린에 다른 **항혈소판제** 하나를
더해 함께 먹습니다(이중 항혈소판요법).

기간은 대개 6~12개월

시술 이유와 출혈 위험에 따라 의사가 기간을
정하고, 이후 한 가지 약으로 줄입니다.

하루도 임의 중단 금지

특히 시술 뒤 첫 몇 달, 급성 심근경색 뒤
1년 안에는 절대 스스로 끊지 않습니다.

그림 · 스텐트 그물 안에 혈전이 생긴 모습입니다(설명용 그림).

근거 · 2025 ACC/AHA 급성 관상동맥증후군 · 2023 ACC/AHA

심방세동에는 아스피린이 아니라 항응고제

심장 안에 생긴 혈전이 뇌로 날아가 뇌졸중을 일으킵니다

뇌졸중 위험 점수로 정합니다

나이·고혈압·당뇨·심부전·뇌졸중 병력 등을
더한 점수로 **항응고제**가 필요한지 정합니다.

대개 새 경구 항응고제

기계 판막·중등도 이상 승모판 협착 등 판막 상태를 보고
고릅니다. 위장 출혈이 걱정되면 약을 골라 씁니다.

스스로 줄이지 않기

기준 없이 용량을 줄이면 오히려 뇌졸중 위험이 높아집니다.

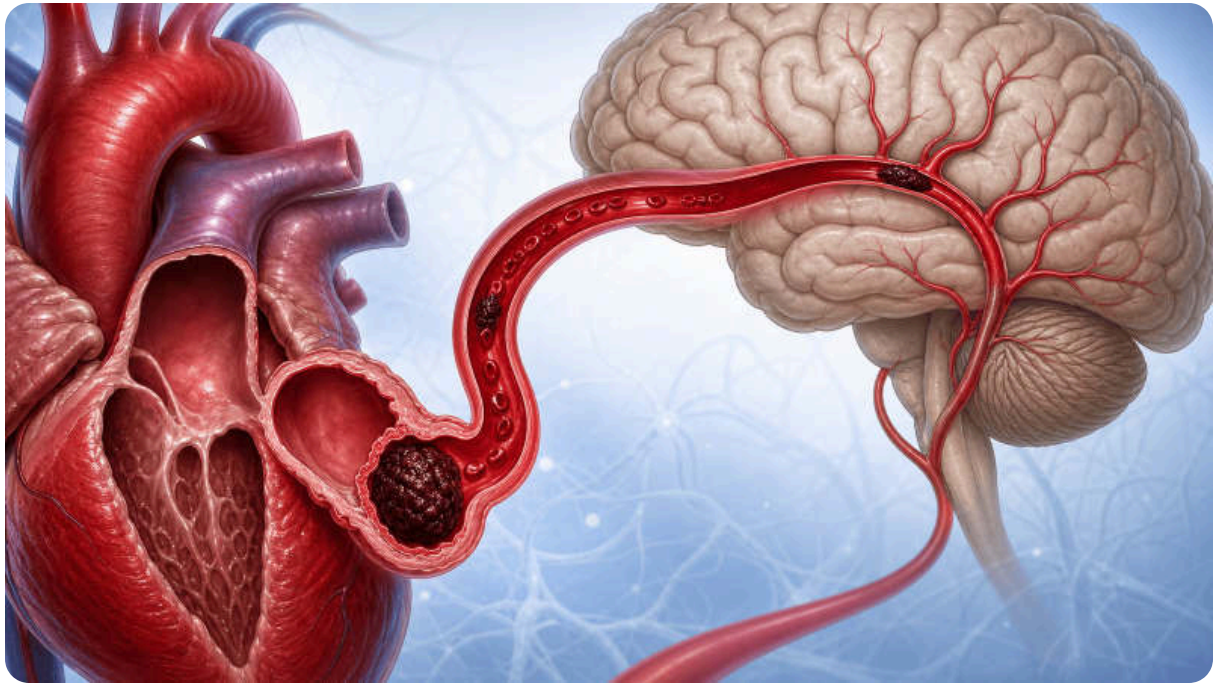


그림 · 심장에서 생긴 혈전이 뇌혈관을 막는 과정입니다(설명용 그림).

근거 · 2024 ESC 심방세동 · 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS

아스피린, 이제 누구나 먹는 약이 아닙니다

병을 겪은 뒤의 재발 예방과, 병이 없을 때의 예방은 권고가 다릅니다

병이 없는 분의 예방

심혈관 병력이 없다면 **신중하게** 정합니다.

- 60세 이상은 새로 시작하지 않는 쪽을 권합니다
- 40~59세는 위험이 높고 출혈 위험이 낮을 때만 개별 결정
- 이미 드시던 분도 75세 무렵 중단을 상의합니다
- 위궤양·출혈을 겪은 분은 피합니다

병을 겪은 분의 재발 예방

심근경색·뇌경색·스텐트 병력이 있다면 처방받은 약을 **계속** 드십니다.

- 심근경색·스텐트 뒤에는 항혈소판제를 꾸준히 먹는 것이 표준입니다
- 뇌경색은 원인에 따라 약이 다릅니다 — 심방세동이 원인이면 대개 항응고제, 아니면 항혈소판제
- 스스로 끊으면 혈전 위험이 올라갑니다
- 위 출혈이 걱정되면 위 보호약을 함께 씁니다

Tip · 지금 아스피린을 드신다면, 어느 쪽 목적으로 드시는지 진료 때 확인해 보세요.

근거 · USPSTF 2022 · ASPREE·ARRIVE·ASCEND 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

뇌혈관 스텐트 뒤에는 신경외과의 약 계획을 따릅니다

뇌동맥류 스텐트 보조 코일색전술은 스텐트 안 혈전을 막는 항혈소판제가 필요합니다

1

스텐트 안 혈전 예방

아스피린과 **클로피도그렐** 두 약을 통상 3~6개월 함께 씁니다. 시술한 신경외과가 기간을 정합니다.

2

출혈 변화 살피기

출혈 위험은 아스피린 단독 연 1.3%에서 병용 연 2.4%입니다. 갑작스러운 신경 증상은 즉시 평가합니다.

3

내시경·수술 전 협진

출혈 위험과 혈전 위험을 함께 비교합니다. 신경외과와 시술 의사가 복용 계획을 정하며 스스로 끊지 않습니다.

뇌혈관 시술 → **처방대로 복용** → **시술 전 함께 조정**

심장 혈관 스텐트의 심근경색 예방 계획과 구분해서 상담합니다.

아산 28회 연수강좌 — 검진에서 발견된 뇌동맥류: 어떻게 추적하고 언제 치료할까?(박중철)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내시경·시술 전, 약은 이렇게 정합니다

'다 끊고 오세요'는 위험합니다 — 약마다, 시술마다 다릅니다



1

일정이 잡히면

시술 날짜가 정해지면
바로 알립니다.

2

약 이름 알리기

먹는 '피 약' 이름과 이유(스텐트·**심방세동** 등)를 알립니다.

3

의사들이 함께 결정

끊을지, 며칠 전 끊을지는 **처방 의사와 시술 의사**가 정합니다.

4

지혈 확인 뒤 다시

피가 멎은 것을 확인하면
가능한 빨리 다시 시작합니다.

Tip · 최근 스텐트·심근경색·뇌졸중·기계 판막이 있으면 검진센터나 의원에서 혼자 끊도록 정하지 않습니다.

근거 · ACG-CAG 2022 · 한국 IDEN 합의 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

이런 신호는 바로 응급실로 가세요

출혈을 되돌리는 치료가 병원에 준비돼 있습니다

01

위장관 출혈

짜장처럼 검고 끈적한 변, 피를 토함, 갑자기 어지럽고 창백해짐.

02

뇌출혈 의심

갑작스러운 **심한 두통**, 한쪽 팔다리 마비, 말이 어눌해짐, 의식이 흐려짐.

03

멈추지 않는 출혈 · 가슴

눌러도 멈추지 않는 출혈, 가슴 **통증**이나 숨이 참.

04

응급실에서 알릴 것

먹는 약 이름과 **마지막으로 먹은 시각**을 꼭 알려 주세요. 약에 맞는 해독 치료를 고릅니다.

Tip · 약 이름과 복용 시각을 휴대폰 메모에 적어 두면 응급 상황에서 바로 보여 줄 수 있습니다.

근거 · 각 약제 허가 정보 · 2024 ESC

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

안전하게 약을 드시는 여덟 가지

스스로 끊거나 줄이지 말고 처방 의사와 상의하세요

01 '피 약'은 종류가 다릅니다 — **내 약 이름**을 압니다

02 스텐트 뒤 약은 **하루도** 임의로 끊지 않습니다

03 심방세동은 아스피린이 아니라 **항응고제**로 막습니다

04 60세 이상 예방 목적 아스피린은 새로 시작하지 않는 쪽

05 치과·내시경·수술 전 먹는 약을 먼저 알립니다

06 진통소염제·한약·건강기능식품도 출혈을 늘릴 수 있어 함께 알립니다

07 **임신** 중이거나 계획 중이면 바로 처방 의사·산부인과에 알립니다

08 다른 약(위장약 포함)을 새로 먹거나
콩팥·간 기능이 나빠지면 알립니다

Tip · 검은 변·피 토함·심한 두통·한쪽 마비·숨 참이 있으면 바로 응급실로 가세요.

근거 · 2025 ACC/AHA · 2024 ESC · USPSTF 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 내시경 전 준비와 확인표는 내시경 전 항혈전제 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

'피 묽게 하는 약'(항혈소판제·항응고제)을 드시는 분을 위한
설명자료입니다. 약을 끊거나 바꾸는 결정은 처방 의사와 상의해 정합니다.

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

참고한 자료

2025 ACC/AHA 급성 관상동맥증후군 · 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS 심방세동 · 2024 ESC 심방세동 · USPSTF 2022 · ACG-CAG 2022 · 한국 IDEN 합의 2024